

TEMA 4.2 • GASTROENTEROLOGÍA

Diarrea Aguda, Crónica y Constipación

PERFIL EUNACOM 1.04.1.026  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definiciones

- La diarrea se define bajo dos parámetros principales que alteran el hábito defecatorio basal del paciente:
- Consistencia:** Disminución de la consistencia (deposiciones más blandas o acuosas).
- Frecuencia:** Aumento en el número de deposiciones, considerando patológico **más de 3 veces al día**. (Lo normal es desde 3 veces al día hasta una vez cada 3 días).

Clasificación según temporalidad

| TABLA 4.2.1: TIPO VS DURACIÓN |               |
|-------------------------------|---------------|
| TIPO                          | DURACIÓN      |
| Aguda                         | < 2 semanas   |
| Prolongada                    | 2 a 4 semanas |
| Crónica                       | ≥ 4 semanas   |

Diarrea Aguda

La etiología suele ser infecciosa. Las causas **virales** (como el Rotavirus) son mucho más frecuentes que las **bacterianas** (como *Escherichia coli*).

NOTA CLÍNICA

En la práctica clínica habitual, no se estudia la etiología de cada cuadro de diarrea aguda; el diagnóstico es clínico y el manejo es sintomático. Sin embargo, existe una **vigilancia epidemiológica** mediante "centros centinela" (SEREMI) para monitorear los agentes circulantes en la comunidad.

Manejo de la Deshidratación

El pilar fundamental del tratamiento es la **hidratación**. El método de rehidratación depende del estado hemodinámico y la pérdida de peso estimada:

| TABLA 4.2.2: PLAN VS ESTADO DEL PACIENTE |                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN                                     | ESTADO DEL PACIENTE                                                                                        | MANEJO                                                                              |
| Plan A                                   | Deshidratación leve (<5% pérdida peso) o asintomático.                                                     | Sales de Rehidratación Oral (SRO): 100-200 cc tras cada deposición.                 |
| Plan B                                   | Deshidratación moderada (5-10% pérdida peso), irritable, mucosas secas, ojos hundidos.                     | SRO: 50-100 cc/kg en un periodo de 4 a 6 horas. Reevaluar.                          |
| Plan C                                   | Deshidratación severa (>10% pérdida peso), signos de <b>shock hipovolémico</b> , compromiso de conciencia. | Hidratación Endovenosa (EV) con cristaloideos (Suero Fisiológico o Ringer Lactato). |

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente en **Plan B** presenta vómitos, la estrategia es **fraccionar** la hidratación oral (dar a sorbos pequeños o cucharadas) antes de decidir pasar a vía endovenosa.

Excepciones y Consideraciones Especiales

**Hipernatremia:** Si el paciente está en un estado hiperosmolar con sodio elevado, aunque el suero fisiológico es seguro, para el examen se prefiere marcar el uso de **soluciones hipotónicas** (0,45%) o **glucosalinas**. **Indicaciones de Hidratación Endovenosa:** 1. Shock o deshidratación severa. 2. Compromiso de conciencia (riesgo de aspiración). 3. Íleo paralítico o distensión abdominal progresiva. 4. Vómitos incoercibles que impiden la vía oral. **Acceso**

**Vascular Difícil:** Niños: Si no se logra vía periférica, se realiza **osteoclisis** (vía intraósea, generalmente en la tibia). **Adultos:** Se prefiere la **denudación venosa** (el catéter intraóseo puede romperse en hueso adulto).

Tratamiento Farmacológico

**Antidiarreicos (Loperamida):** **NO** se recomiendan en diarrea aguda infecciosa, ya que pueden aumentar el riesgo de complicaciones bacterianas. **Antieméticos:** *Sí se pueden usar si hay vómitos.* **Antiespasmódicos (Viadil):** *Sí se pueden usar para el manejo del dolor cólico.* **Antibióticos:** La regla general es **NO indicar antibióticos**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

**Excepciones donde *Sí* se usan antibióticos:** 1. **Disentería** (sangre en deposiciones): Sospecha de Shigella o E. coli enteroinvasora. 2. **Diarrea del viajero**. 3. **Fiebre persistente** (más de 2-3 días). 4. *Paciente con compromiso del estado general/séptico.*

**Elección de Antibiótico:** Ciprofloxacino (vía oral) o Ceftriaxona/Cefotaxima (vía EV si está grave). **Casos específicos:** *Vibrio cholerae* (Cólera): Azitromicina. *Campylobacter*: Eritromicina o Azitromicina.

Diarrea Prolongada y Crónica

Diarrea Prolongada (2-4 semanas)

La conducta es **buscar el agente infeccioso**, ya que no es normal que un virus o bacteria común dure tanto tiempo. Se solicita: - Coprocultivo. - Rotatest. - Parasitológico de deposiciones (buscar Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, etc.).

Diarrea Crónica (≥ 4 semanas)

El estudio depende de la sospecha clínica: 1. **Funcional (Síndrome de Intestino Irritable):** Dolor cólico que alivia al defecar, distensión, mucosidad. Tratamiento: Educación, manejo del estrés y, a veces, **antidepresivos tricíclicos** (por su efecto anticolinérgico que estríñe). 2. **Malabsorción:** Esteatorrea (grasa) o lentería (alimentos sin digerir). Estudio: Test de Sudan, prueba de la D-Xilosa, anticuerpos para **Enfermedad Celíaca** y Endoscopia Digestiva Alta (EDA). 3. **Enfermedad Inflamatoria Intestinal:** Hematoquecia, fiebre crónica. Estudio: Colonoscopia. 4. **Cáncer de Colon:** Si hay signos de alarma (baja de peso, anemia, mayor de 50 años). Estudio: Colonoscopia. 5. **Post-antibióticos:** Sospechar infección por Clostridioides difficile.

Diarrea por Clostridioides difficile

Se sospecha en pacientes que han usado antibióticos (o estuvieron hospitalizados/post-parto) en el **último mes**.

- Diagnóstico:**
- PCR para toxina:** Es el examen de elección hoy en día por su mayor sensibilidad.
- Toxinas A y B en deposiciones:** Examen clásico y más barato.
- Tratamiento (Algoritmo):**
- 1. **Metronidazol** oral.
- 2. Si falla (no hay respuesta clínica en una semana): Repetir Metronidazol.
- 3. Si vuelve a fallar: **Vancomicina** oral.

**ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**

La respuesta al tratamiento de *C. difficile*\* es **CLÍNICA**. No se debe pedir PCR o Toxinas de control, ya que pueden permanecer positivas mucho tiempo después de la curación.

**Constipación (Estreñimiento)**

- Se define por:
- **Consistencia:** Deposiciones duras (caprinas o "bolitas").
- **Frecuencia:** Menos de 3 veces por semana.

**Manejo de la Constipación**

- **Funcional:** Es lo más frecuente. Se trata con educación, aumento de fibra/agua y fármacos proquinéticos como la **Trimebutina**. - **Signos de alarma:** Ante anemia, baja de peso o cambio brusco del hábito en adultos mayores, se debe solicitar **Colonoscopia** para descartar neoplasia.

**PERLA CLÍNICA EUNACOM**

Recuerda la regla de los 3: - **Diarrea:** > 3 veces al día. - **Constipación:** < 3 veces a la semana.

- **Temas relacionados:**
- **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**
- **Cáncer Colorrectal**
- **Síndrome de Intestino Irritable**
- **Síndrome Hemolítico Urémico**

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 8 meses con diarrea hace 3 días, irritable, mucosas secas, ojos hundidos, con pérdida del 7% de su peso. ¿Cuál es el plan de hidratación más adecuado?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diarrea Aguda, Crónica y Constipación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos
- Tratamiento de diarrea aguda: hidratación según grado de deshidratación (Plan A, B o C)
- No usar antidiarreicos en diarrea aguda; antibióticos solo en disentería, Shigella, diarrea febril prolongada o diarrea del viajero
- Antibiótico de elección: ciprofloxacino; si grave: ceftriaxona IV
- Diarrea por *Clostridium difficile*: diagnóstico con PCR, tratamiento metro-metro-vanco, respuesta se evalúa clínicamente
- Diarrea crónica: manejo según clínica (funcional, signos de alarma, malabsorción, EI o post-antibióticos)
- Constipación funcional: trimebutina; con signos de alarma: colonoscopia para descartar cáncer
- Hipernatremia en deshidratación: usar suero hipotónico o glucosalino en vez de fisiológico

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIARREA AGUDA, CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN)****PREGUNTA 1**

Lactante de 8 meses con diarrea hace 3 días, irritable, mucosas secas, ojos hundidos, con pérdida del 7% de su peso. ¿Cuál es el plan de hidratación más adecuado?

- A)** Plan A: SRO 100-200 cc post deposición
- B)** Plan B: SRO 50-100 cc/kg en 4-6 horas
- C)** Plan C: suero fisiológico endovenoso
- D)** Suero glucosalino endovenoso
- E)** Agua libre por vía oral

**PREGUNTA 2**

Paciente de 45 años con diarrea hace 3 semanas que inició 10 días después de completar tratamiento antibiótico por neumonía. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la etiología?

- A)** Coprocultivo
- B)** Toxinas A y B para *Clostridium difficile*
- C)** PCR para *Clostridium difficile*
- D)** Parasitológico seriado
- E)** Colonoscopia

**PREGUNTA 3**

Paciente con diarrea por *Clostridium difficile* completó un ciclo de metronidazol. La PCR sigue positiva pero la diarrea cedió completamente. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Repetir metronidazol
- B)** Iniciar vancomicina oral
- C)** Considerar respuesta adecuada y observar
- D)** Realizar colonoscopia
- E)** Solicitar toxinas A y B

**RESUMEN: DIARREA AGUDA, CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN**

Clase que aborda la diarrea aguda, prolongada, crónica y constipación. La diarrea se define como deposiciones blandas/acuosas con más de 3 veces al día, clasificándose en aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas) y crónica (>=4 semanas). El manejo de la diarrea aguda se centra en la hidratación según grado de deshidratación: Plan A (SRO 100-200cc post deposición) para leve, Plan B (50-100cc/kg en 4-6h) para moderada, y Plan C (suero fisiológico IV) para severa. No se usan antidiarreicos; los antibióticos solo se indican en disentería, shigela confirmada o diarrea febril prolongada. La diarrea crónica se estudia según la clínica: funcional (manejo del estrés), signos de alarma (colonoscopia), malabsorción (test de Sudán, D-xilosa), o post-antibióticos (buscar *Clostridium difficile*). La constipación se define como menos de 3 deposiciones/semana, con manejo según causa.